ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᑉ ᐸᕐᓇᕈᑎᖓ · PH. D., ᓇᐅᓕᒫᓂᒃ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᖅ

Favoriser la réponse intersectorielle apportée aux différents besoins sociaux et de soins de santé concomitants des personnes aînées vivant à domicile : profils, cartographie des ressources et analyse des réseaux.

Eric Bernier, LL.M. ᐊᒻᒪᓗ M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca erjb-web.github.io
Ph. D., ᓇᐅᓕᒫᓂᒃ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᖅ · ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓰᑦ, ᑎᒥᐅᔪᑦ ᒪᓕᒋᐊᓗ · ESPUM, Université de Montréal

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᖏᒃ
Dres Nadia Sourial ᐊᒻᒪᓗ Géraldine Layani

01 ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

CCSMTL: CLSC-ᑦ ᓄᓇᖏᑦ 8, 48 575 ᐃᓄᐃᑦ 65 ᐅᑭᐅᖏᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ 2026-ᒥ
ISQ, 2026

≈ 3 700

211-ᒧᑦ ᑐᑦᓯᕐᓂᑦ, ᐃᓄᖕᓂᑦ 70 ᐅᑭᐅᖏᓐᓂᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ, 2021-2026
211 Grand Montréal, 2026

691

ᑭᖕᖑᒪᒋᔭᑦ ᐱᔾᔪᑎᖏᑦᑐᑦ, 60 ᐅᑭᐅᖏᓐᓂ ᐅᖓᑖᓄᑦ; ᐃᓅᓇᑎᒃ ᐱᑦᔪᑎᖃᑦᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᓂᒃ
211 Grand Montréal, 2026

ᐱᖓᓱᑦ ᑐᑭᖏᑦ ᐊᕙᑦᑐᒥᐊᓖᑦ
ᐃᓇᑐᕿᑦ ᐊᖏᕐᕿᒥᓂ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᔪᑦ, ᐃᓅᓯᕐᒥ ᑭᖕᖑᒪᒋᔭᖏᑦ ᑲᑎᑦᓯᒪᔪᑦ; ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᖅ CLSC-ᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᐋᕿᓯᕐᑕᐅᓲᖅ.

Besoins concomitants

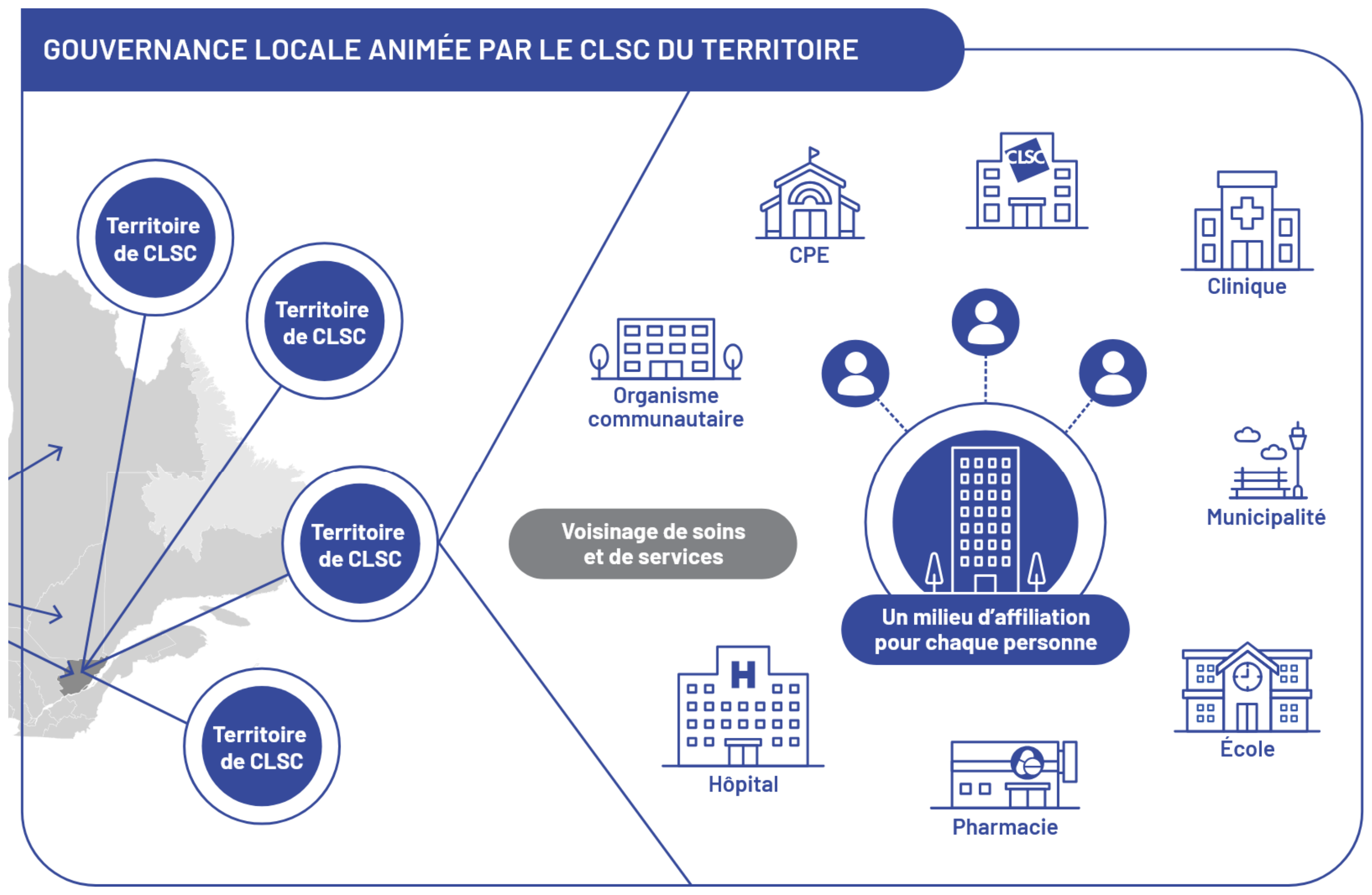
Besoins sociaux et de soins de santé présents chez les mêmes personnes.

Personnes aînées vivant à domicile

personnes aînées vivant à domicile présentant des besoins sociaux et de soins de santé concomitants susceptibles de nécessiter une réponse intersectorielle en première ligne.

ᓄᓇᒥ ᐋᕿᓯᕐᑕᐅᓲᖅ
ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᓂᖏᑦ
ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᖏᑦ, ᐃᓗᓯᓕᕆᔨᓂᒃ ᐱᓇᓱᒃᑎᖃᕐᓱᑎᒃ, ᐃᓗᓯᕐᓯᓯᐊᕐᓂᒧᑦ ᓱᕐᕚᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᖅᑲᖓᑦᑎᐊᕐᓂᖅ: ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓗᓯᓕᕆᓂᖏᑦ, ᐱᒍᑦᔨᒥᐊᖕᖑᒍᑏᑦ, ᑲᕙᒪᒧᑦ ᖃᓂᑦᑐᑦ, ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑎᒥᐅᔪᑦ, ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᑦ, ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᖅ.
MSSS, 2017 ; Leppo et al., 2013

ᐱᒍᑦᔨᒥᐊᖕᖑᒍᑎᓄᑦ ᒪᓕᒐᖅ · MSSS, 2026
CLSC-ᐅᑉ ᓄᓇᖓ ᑐᖕᖓᕕᐅᓕᖅᑐᖅ



CLSC-ᐅᑉ ᓯᑕᒪᑦ ᐱᔪᑦᓴᖏᑦ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᔨ · ᐊᑕᐅᑦᓯᕈᑎᔨ · ᑎᒥᐅᔪᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎ · ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᖃᑕᐅᔪᖅ

« ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ » · MSSS, 2026, p. 42 · ᐊᑦᔨᖑᐊᖅ : MSSS, 2026

Comment s'organise la réponse intersectorielle aux besoins sociaux et de soins de santé concomitants des différents profils de personnes aînées vivant à domicile ?

O1
Identifier les différents profils de personnes aînées vivant à domicile présentant des besoins sociaux et de soins de santé concomitants susceptibles de nécessiter une réponse intersectorielle en première ligne.

O2
Cartographier les ressources territoriales susceptibles d'être mobilisées en première ligne pour répondre aux besoins sociaux et de soins de santé concomitants des différents profils de personnes aînées vivant à domicile, et caractériser les variations territoriales de leur disponibilité, de leur diversité, de leur complémentarité et de leur accessibilité.

O3
Analyser les configurations organisationnelles des réseaux intersectoriels en première ligne mobilisés sur le territoire pour répondre aux besoins sociaux et de soins de santé concomitants des différents profils de personnes aînées vivant à domicile, afin de caractériser leurs modalités de fonctionnement.

02 Méthodologie proposée

PROTOCOLE PROVISOIRE · terrains, partenariats et autorisations à confirmer

Méthodologie actualisée en français, version de référence. Traduction autochtone à valider ; aucun nouveau texte scientifique n'est inventé.

Objectif méthodologique O1

Conduire une revue de la littérature scientifique afin d'identifier et de caractériser les différents profils de personnes aînées vivant à domicile présentant des besoins sociaux et de soins de santé concomitants susceptibles de nécessiter une réponse intersectorielle en première ligne et de déterminer les besoins associés à chacun de ces profils.

Revue de portée · 4 bases

- recherche documentaire systématique, critères d'admissibilité explicites et sélection par deux évaluateurs indépendants.
- populations, contexte de première ligne, définitions des besoins sociaux et de soins de santé, instruments, concomitance chez les mêmes personnes et profils rapportés.
- revue de portée selon JBI ; compte rendu PRISMA-ScR. Synthèse descriptive des définitions, besoins associés et configurations documentées.

Objectif méthodologique O2

Réaliser une étude cartographique et spatiale des ressources mobilisables en première ligne pour répondre aux différents besoins sociaux et de soins de santé concomitants associés aux profils de personnes aînées vivant à domicile afin de caractériser, dans les différents territoires de CLSC, leur distribution, leur disponibilité, leur diversité, leur complémentarité et leur accessibilité territoriale.

6 secteurs · analyse écologique

- repérage systématique des ressources admissibles dans les sources retenues ; règles d'inclusion et de dédoublonnage explicites.
- localisation, secteur, besoins concernés, disponibilité documentée, modalités d'accès, admissibilité, horaires et capacité lorsqu'ils sont renseignés.
- étude cartographique et spatiale dans R et QGIS ; distribution, disponibilité, diversité, complémentarité et accessibilité territoriale.

Objectif méthodologique O3

Mener une analyse rétrospective des réseaux sociaux (ARS) intersectoriels mobilisés en première ligne à partir de territoires de CLSC pour répondre aux besoins sociaux et de soins de santé concomitants des différents profils de personnes aînées vivant à domicile, afin de caractériser leur composition, la structure de leurs relations ainsi que la nature et l'intensité des collaborations entre acteurs.

Questionnaire unique · 12 mois · réseaux entiers et égocentrés

- un questionnaire relationnel unique, administré une fois aux acteurs des organisations, sur les 12 derniers mois .
- matrice des relations entre toutes les organisations du périmètre de chaque territoire ; composition, structure et fonctionnement, selon la couverture obtenue.
- entourage des organisations ou équipes focales, dont le CLSC ; taille, diversité et liens ego-alter. Les liens alter-alter exigent un recueil explicite.

O1 : profils · O2 : ressources · O3 : réseaux. ARS quantitative observationnelle rétrospective, dans plusieurs territoires de CLSC contrastés.

03 Produits attendus · aucun résultat de thèse présenté

Profils étayés + vignettes

Atlas + matrice besoins-ressources-territoire

Réseaux contextualisés + mécanismes

04 Retombées visées

Éclairer les écarts entre besoins, offre accessible et aide mobilisée ; discuter des pistes d'organisation avec les personnes concernées et les acteurs du territoire. Aucun bénéfice individuel garanti.

Contact ≠ collaboration ≠ aide reçue ≠ besoin résolu. Les chiffres du 211 et les cartes de contexte sont illustratifs ; ils ne remplacent pas la collecte O3.

Brewster, Tan, & Yuan (2019). Health Services Research, 54(6), 1246-1254. doi:10.1111/1475-6773.13206 · AHRQ (2014), Care Coordination Measures Atlas, ch. 4.